TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 7 Tiếp cận sốt trẻ em

Tóm tắt từ tài liệu Tiếp cận sốt trẻ em.pdf (15 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa - Offline

1. ĐẠI CƯƠNG
2. ĐỊNH NGHĨA
3. CƠ CHẾ BỆNH SINH
4. NGUYÊN NHÂN
5. PHÂN LOẠI SỐT
6. TIẾP CẬN SỐT CẤP
7. XỬ TRÍ
8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO)
9. THAM VẤN CHA MẸ

1. ĐẠI CƯƠNG

- Sốt rất thường gặp trong bệnh nhiễm trùng trẻ em; nguyên nhân **đa số do siêu vi**, kế đến vi khuẩn. Trẻ nhỏ dễ **co giật** khi sốt cao, trẻ lớn hay nhức đầu, đôi khi la sảng.
- Trẻ < 5 tuổi: sốt gây tử vong thường do **viêm phổi, sốt rét, sởi, sốt xuất huyết, viêm não – màng não**. Trẻ **dưới 2 tháng**: nhiễm trùng sơ sinh, nhiễm trùng huyết, viêm màng não gram âm.
- Trẻ **3 tháng – 3 tuổi** có **5–6 đợt sốt mỗi năm**; khoảng **9%** trẻ đến cấp cứu có nhiễm trùng nặng.

2. ĐỊNH NGHĨA

- Sốt là **phản ứng sinh lý có lợi**: tăng diệt khuẩn, tăng đề kháng (thực bào, interferon, kháng thể), **giảm sắt tự do** trong huyết thanh (vi khuẩn cần sắt). Nguyên tắc: **chỉ hạ sốt khi sốt quá cao hoặc gây khó chịu**; quan trọng là **tìm nguyên nhân**.
- **Sốt khi nhiệt độ hậu môn ≥ 38°C.** Bình thường 36,6–37,9°C (hậu môn), cao nhất buổi tối, thấp nhất buổi sáng.
- So với hậu môn: miệng thấp hơn khoảng **0,4°C**, **ống tai thấp hơn khoảng 0,8°C**, **trán và nách thấp hơn khoảng 0,5°C**; đo ngoại biên dao động nhiều hơn.

3. CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Thân nhiệt điều hòa ở **vùng hạ đồi**. Sốt do **tăng điểm điều nhiệt** (ví dụ từ 37°C lên 39°C) dưới tác dụng của **chất gây sốt nội sinh**: **IL-1, IL-6, TNF-α, interferon**. **Prostaglandin E2** là thành phần quan trọng nhất, gắn thụ thể ở hạ đồi tạo điểm điều nhiệt mới.
- **Chất gây sốt ngoại sinh:** vi sinh vật, độc tố (nội độc tố), thuốc (**vancomycin, amphotericin B, allopurinol**) kích thích tạo chất gây sốt nội sinh.
- Khi điểm điều nhiệt tăng: **co mạch ngoại biên** (bắt đầu ở bàn tay, bàn chân) → trẻ thấy **lạnh**, **run** sinh nhiệt; thường tăng 1–2°C. Khi điểm điều nhiệt về bình thường: **giãn mạch, đổ mồ hôi**.
- **Sốt cao (hyperpyrexia) > 41,5°C:** gặp trong nhiễm trùng nặng, xuất huyết thần kinh trung ương; **ít khi do nhiễm trùng**, cần **cấp cứu**.
- **Tăng thân nhiệt khác (hyperthermia):** thân nhiệt tăng **không kiểm soát** trong khi **điểm điều nhiệt không đổi** (tiếp xúc nguồn nhiệt, sốc nhiệt, ngộ độc salicylate, tăng thân nhiệt ác tính) → **không đáp ứng thuốc hạ sốt**, có thể tử vong nhanh.

4. NGUYÊN NHÂN

- **Nhiễm trùng:**
  - **Siêu vi** là hàng đầu, thường tự giới hạn sau **5–7 ngày** (CMV, viêm gan có thể sốt kéo dài). **Sốt xuất huyết dengue:** sốt cao đột ngột, liên tục **2–7 ngày**, xuất huyết. **Tay chân miệng: CA16** và **EV71**

(EV71 nặng, có thể tử vong).
    - **Vi khuẩn:** hô hấp, tiêu hóa, **tiết niệu** (sốt có thể là triệu chứng duy nhất ở trẻ nhỏ), tai.
    - **Ký sinh trùng: sốt rét** nếu sống hoặc đến vùng dịch tễ trong **6 tháng** gần nhất.
    - **Lao:** quan trọng, nhất là sốt kéo dài.
- **Không nhiễm trùng:** bệnh miễn dịch, **sốt do thuốc** (thường do dị ứng; phenothiazine, kháng cholinergic), tổn thương thần kinh trung ương, đái tháo nhạt, **ác tính** (leukemia, lymphoma), tổn thương mô (nhồi máu, chấn thương, bỏng).

5. PHÂN LOẠI SỐT

- **Sốt cấp có dấu hiệu gợi ý:** viêm hô hấp, viêm ruột, sốt xuất huyết (tử ban), tay chân miệng (mụn nước, lở họng); hiếm hơn viêm màng não, viêm khớp, viêm tủy xương.
- **Sốt cấp không dấu hiệu gợi ý:** thường **dưới 3 tuổi**; chia **dưới 3 tháng** và **3–36 tháng**.
    - **Dưới 3 tháng:** siêu vi **40–60%** nhưng **nhiễm khuẩn huyết nặng 10–15%** → nếu nguy cơ cao: nhập viện, cấy máu, nước tiểu, **kháng sinh ngay**.
    - **3–36 tháng:** đa số siêu vi tự giới hạn; **nhiễm khuẩn huyết ẩn 1,5%** (do vi khuẩn có vỏ: Hib, phế cầu, não mô cầu, Salmonella), giảm còn **0,5%** nếu đã chủng Hib và phế cầu; nhiễm khuẩn nặng hay gặp nhất là **nhiễm trùng tiểu**.
- **Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân (FUO):** thân nhiệt hằng ngày **> 38°C ít nhất 8–14 ngày**, chưa rõ nguyên nhân sau đánh giá bước đầu (thời gian thay đổi 8 ngày – 3 tuần).

6. TIẾP CẬN SỐT CẤP

6.1. Bệnh sử, tiền căn

- **Tính chất sốt:** dao động (nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng tiểu); **liên tục** dao động < 0,5°C (**thương hàn**); **sốt cơn** về bình thường (**sốt rét**); **hai giai đoạn kiểu lạc đà** (leptospirosis, **dengue**); **sốt chu kỳ** (**PFAPA**, sốt Địa Trung Hải).
- Tiền căn: sản khoa, **chủng ngừa**, nhiễm trùng tiểu, co giật, sinh non, ống thông, thuốc; **dịch tễ địa phương** (sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng), **du lịch**.

6.2. Dấu hiệu bệnh nặng

- **Nhiễm khuẩn huyết nặng ở trẻ < 3 tháng:** quan trọng nhất là **vẻ mặt nhiễm trùng nhiễm độc, trông không khỏe**; da tái, tím, lừ đừ, thở nhanh, đổ đầy mao mạch chậm.
- **Nhiễm khuẩn huyết ẩn ở trẻ 3–36 tháng: sốt ≥ 39°C**, **bạch cầu ≥ 15.000/mm³**, tăng đa nhân trung tính, CRP, VS.
- **Nhiễm trùng huyết:** SIRS (2/4 tiêu chuẩn: thân nhiệt, nhịp tim, nhịp thở, bạch cầu) + nhiễm trùng → nặng (rối loạn cơ quan) → **sốc nhiễm trùng** (hạ huyết áp kéo dài > 1 giờ dù truyền dịch, vận mạch) → MODS.

6.3. Cận lâm sàng (NICE, trẻ < 5 tuổi không dấu hiệu gợi ý)

- **Nguy cơ cao:** công thức máu, **cấy máu**, CRP, **xét nghiệm nước tiểu**; tùy lâm sàng chọc dò thắt lưng, X-quang ngực. **Phải cấy máu, nước tiểu, dịch não tủy trước khi dùng kháng sinh.**
- **Nguy cơ thấp:** xét nghiệm nước tiểu; không cần xét nghiệm máu, X-quang.
- **Nguy cơ trung bình:** nước tiểu, công thức máu, CRP; cấy máu, X-quang nếu sốt > 39°C và bạch cầu > 20.000; **chọc dò thắt lưng nếu trẻ < 1 tuổi**.

6.4. Dấu hiệu báo động và nhập viện

- **Báo động:** trẻ < 2 tháng; ngủ gà, lừ đừ, vẻ nhiễm trùng nhiễm độc; suy hô hấp; **tử ban**; **quấy khóc vô cớ không dỗ được**.
- **Nhập viện gấp: trẻ < 2 tháng có nhiệt độ ≥ 38°C** bất kể triệu chứng khác; trẻ ≥ 2 tháng có **không uống được hoặc bỏ bú, nôn tất cả, co giật, li bì khó đánh thức, cổ gượng, thóp phồng, sốc, xuất huyết da niêm**.
- Trước chuyển viện: **liều kháng sinh đầu**, **phòng hạ đường huyết**, hạ sốt nếu cần.

7. XỬ TRÍ

7.1. Hạ sốt

- Không phải lúc nào cũng cần; không bắt buộc đưa nhiệt độ về bình thường.
- **Chỉ định:** sốc; bệnh thần kinh, hô hấp – tuần hoàn, rối loạn chuyển hóa; **sốt ≥ 41,5°C**; **không dung nạp sốt** (khó chịu, quấy khóc).
- **≥ 39°C:** cân nhắc thuốc; **< 39°C:** thường không cần; hạ sốt **không thay đổi diễn tiến bệnh hay nguy cơ co giật**. **Lau mát chưa chứng minh tốt hơn thuốc**, chỉ có tác dụng tạm thời.

Thuốc	Liều	Lưu ý
Acetaminophen (paracetamol)	**10–15 mg/kg/lần**, uống mỗi **4–6 giờ**	Ít tác dụng phụ; kéo dài hại thận, **quá liều gây suy gan**
Ibuprofen	**5–10 mg/kg/lần**, uống mỗi **6–8 giờ**	Khó tiêu, **xuất huyết tiêu hóa**, giảm tưới máu thận

7.2. Điều trị đặc hiệu

- Có dấu hiệu gợi ý: theo nguyên nhân.
- Không dấu hiệu gợi ý + **dấu hiệu bệnh nặng**: kháng sinh kinh nghiệm **sau khi cấy máu, nước tiểu**; trẻ 3–36 tháng thường dùng **cephalosporin thế hệ 3**.
- Không dấu hiệu gợi ý + không dấu hiệu nặng: **theo dõi 72 giờ, tái khám ít nhất mỗi 24 giờ**.
- **Theo dõi ngoại trú trẻ < 3 tháng** khi: **≥ 4 tuần tuổi**, trông khỏe, không dấu định vị, không sinh non, không dùng kháng sinh, **bạch cầu 5.000–15.000**, nước tiểu < 10 BC/quang trường, dễ tái khám.

8. SỐT KÉO DÀI KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN (FUO)

- Nguyên nhân: **nhiễm trùng (~40%, thường gặp nhất**; ở Việt Nam: **lao, thương hàn, sốt rét**), tự miễn (10–20%: Still, lupus, thấp tim), **ác tính (~10%)**: lymphoma, leukemia, neuroblastoma; khoảng **25% không tìm thấy nguyên nhân**. Tiên lượng khá tốt.
- Chẩn đoán phân biệt: **sốt giả tạo (hội chứng Munchausen)**, sốt tái diễn, sốt chu kỳ (**giảm bạch cầu chu kỳ mỗi 21 ngày**, PFAPA).
- Xét nghiệm theo bước: ban đầu CTM, **VS (giá trị hơn CRP trong bệnh mạn)**, men gan, nước tiểu, cấy máu, X-quang ngực, xét nghiệm miễn dịch; bước 2: cấy họng, phân, **tuberculin**, huyết thanh thương hàn, viêm gan B, EBV, HIV; bước 3: chọc dò tủy sống, CT/MRI, **tủy đồ**.
- Xử trí: **sinh hiệu không ổn định → điều trị kinh nghiệm**; ổn định → tiếp tục xét nghiệm, điều trị đặc hiệu khi có nguyên nhân, nếu không thì hạ sốt.

9. THAM VẤN CHA MẸ

- Sốt là **đáp ứng bình thường** với nhiễm trùng, là **triệu chứng không phải bệnh**; quan tâm **sự thoải mái của trẻ hơn con số nhiệt độ**; thuốc hạ sốt chỉ giảm tạm thời, phải **điều trị nguyên nhân**.

- Phòng ngừa: **rửa tay bằng xà phòng**, che miệng khi ho, hắt hơi, **tiêm chủng đầy đủ**, ăn đủ rau quả, ngủ đủ.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Tiếp cận sốt trẻ em.pdf khi cần chi tiết.